

綜合判定	
C	要經過觀察

既往・手術歴	特記事項なし		服薬・喫煙歴	血圧服薬	なし
				糖尿服薬	なし
				脂質服薬	なし
	手術歴なし		喫煙歴	なし	

メタボリックシンドローム

判定	非該当	保健指導 レベル	情報提供
----	-----	-------------	------

検査項目		今回	前回	前々回	参考基準値
		2025年5月7日			
受診番号		35			
身体計測	身長	162.8			cm
	体重	50.6			kg
	腹囲	72.5			85未満 cm
	体脂肪率				25以下 %
	BMI	19.1			18.5~24.9 kg/m ²
視力	標準体重	58.3			kg
	右(矯正)	(1.2)	()	()	1.0以上
聴力	左(矯正)	(0.8)	()	()	1.0以上
	色覚				
血液一般像	1000Hz (右/左)	所見なし 所見なし			
	4000Hz (右/左)	所見なし 所見なし			
血液一般像	会話法				
	白血球	81			31~84 10 ³ /mm ³
	赤血球	499			400~539 10 ⁴ /mm ³
	ヘモグロビン	13.6			13.1~16.3 g/dℓ
	ヘマトクリット	42.6			38.5~48.9 %
	MCV	85.4			83.0~102.9 fℓ
	MCH	↓ 27.3			27.9~34.5 pg
	MCHC	31.9			31.4~35.5 %
	血小板	27.7			14.5~32.9 10 ⁴ /mm ³
	好中球				35~73 %
脂質	リンパ球				20~51 %
	単球				2~12 %
	好酸球				0~8 %
	好塩基球				0~3 %
肝機能	異型リンパ球				0.0~0.9 %
	総コレステロール	163			mg/dℓ
	中性脂肪	44			30~149 mg/dℓ
	HDLコレステロール	65			40以上 mg/dℓ
	LDLコレステロール	88			60~139 mg/dℓ
肝機能	non-HDL	98			90~149 mg/dℓ
	L/D比				
	AST(GOT)	14			30以下 U/ℓ
	ALT(GPT)	9			30以下 U/ℓ
	γ-GTP	16			50以下 U/ℓ
	ALP				38~113 U/ℓ
	A/G比				1~2
	総ビリルビン				0.3~1.2 mg/dℓ
	総蛋白				6.5~7.9 g/dℓ
	アルブミン				3.9以上 g/dℓ
肝機能	LDH				124~222 U/ℓ
糖代謝	HBs抗原				(-)
	HCV抗体				(-)
糖代謝	尿糖	(-)			(-)
	空腹時血糖	73			100未満 mg/dℓ
	食後血糖				140未満 mg/dℓ
	HbA1c	↑ 5.7			5.5以下 %
腎臓					
	尿素窒素				8~22 mg/dℓ
	クレアチニン				1.00以下 mg/dℓ
尿酸	eGFR				60以上 mL/min
	血清アミラーゼ				37~131 U/ℓ
痛風					
	尿酸				2.1~7.0 mg/dℓ
尿検査					
	尿蛋白	(-)			(-)
	尿潜血	(-)			(-)
	ウロビリノーゲン				(±)
便検査	尿赤血球				5未満/HPF
	尿白血球				5未満/HPF
	尿扁平上皮				1未満/HPF
便	1回目				(-)
	2回目				(-)

胸 部	今回	2025年5月7日	前回		前々回	
	異常なし					
	検査法	X線(デジタル)	検査法		検査法	
肺機能	今回		前回		前々回	基準値
	肺活量					80%以上
	%肺活量					
	1秒量					70%以上
	1秒率					

血 圧		今回	2025年5月7日	前回		前々回		基準値
	1.最高/最低	102 / 43		/		/		
	2.最高/最低	/		/		/		
心電図	今 回	2025年5月7日		前 回			前々回	
	正常							
眼 底	今 回			前 回			前 回	

胃 部	今 回		前 回		前々回		
	検査法		検査法		検査法		
腹 部 超音波	肝臓				腎臓		
	胆のう				脾臓		
	膵臓				その他		

今回の診察では異常ありません	頭痛

[illegible]

医療法人社団 令樹 **medock** 総合健診クリニック
141-0021 東京都品川区上大崎3-11-18 TEL:03-5860-2635
院長:須磨 久善

健康診断結果のご案内

〒125-0041

東京都葛飾区東金町3-38-8

臼倉マンション202

Mazumder Rajarshi 様
健康診断結果票 在中

判定基準



A	今回の検査の範囲では異常はありません。
B	わずかに異常を認めますが、日常生活に差し支えありません。
C	経過観察あるいは生活習慣の改善を要します。
C●	●か月後の再検査を要します。
D2	二次検査（精密検査）を必要とします。
D1	受診を必要とします。（かかりつけ医、または専門医を受診してください。）
E	現在治療中の疾患については、今後も治療を継続してください。

E判定(治療中)について

E判定は、現在医療機関に通院して治療を受けている、あるいは具合の悪いときだけ医療機関で診てもらっている疾病に関する項目です。結果の良し悪しにかかわらず、主治医にお見せいただき確認してもらってください。

血液検査項目の見方

検 査 項 目		検査の説明	検 査 項 目		検査の説明
BMI		肥満度を表す指標で、(体重kg)÷(身長m)÷(身長m)で算出されます。Body Mass Indexの頭文字で国際的に使用されている指標です。日本人はこの値が「22」のときに最も病気になりにくいといわれています。	肝機能等	AST(GOT) ALT(GPT)	体の蛋白質を構成するアミノ酸を作るのに必要な酵素で、体のあらゆるところにありますが、特に肝臓に多く含まれます。また、ASTは心臓や筋肉にも多く含まれます。従って、AST、ALTともに高い時は肝臓の障害が疑われます。
標準体重		(身長m)×(身長m)×22で算出されます。「22」はBMIの標準値です。		γ-GTP	肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。特にアルコールの飲み過ぎや肥満により高値を示します。
腹囲		BMIには内臓脂肪が表れにくいという欠点があるため、メタボリックシンドロームの判定基準には、腹囲の結果が用いられています。		ALP	肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。また、骨や甲状腺の障害でも高値となる特徴があります。
体脂肪率		体重に占めるおおよその脂肪の割合を表します。		HBs抗原 HCV抗体	肝炎には、ウイルス性肝炎、自己免疫性肝炎、薬物性肝炎、アルコール性肝炎などがあります。肝炎をおこすウイルスとして、日本人にはB型・C型肝炎ウイルスが多く、肝硬変や肝がんの原因になりやすいため、検査を行っています。肝炎ウイルス検査が初めて陽性になった場合、精密検査を行い、現在の肝炎ウイルスの状態を評価する必要があります。
視力		裸眼もしくは矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ使用)の測定値となります。5mの距離の設定で測定した視力です。	脂質代謝	総コレステロール(T-CHO) HDL-コレステロール(HDL-C) LDL-コレステロール(LDL-C)	血液に含まれるすべてのコレステロールの総量を、総コレステロールといいます。コレステロールの中には動脈硬化を促進するLDL(悪玉)コレステロールと、動脈硬化の予防に働くHDL(善玉)コレステロールがあります。HDLコレステロールが多いと動脈硬化になりにくいといわれ、長寿につながるとされています。しかしアルコールの多飲や脂質代謝異常の疾患で上昇することもあります。中性脂肪は本来なら身体のエネルギー源となりますが、血中で多くなり過ぎると、動脈硬化を進める可能性があります。太り過ぎや食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎ、運動不足によって高い数値が出ることがあります。
尿検査	糖	(+)以上は糖尿病を疑います。血液検査結果と併せて総合的に判断します。		尿素窒素(BUN) クレアチニン(CRE)	クレアチニン、尿素窒素は体内で使用された蛋白質の老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると尿中への排泄が減少し、血液中に増加します。血中のクレアチニンと性別、年齢から計算して「腎臓のろ過機能」を推定する値が、「eGFR」です。eGFRが60未満で3ヶ月以上持続する場合に慢性腎臓病とされ、将来透析になるリスクが高くなります。
	蛋白	陽性(+)の場合、腎臓の障害が疑われますが、発熱や疲労などで一時的に陽性になることもあります。	腎機能	ナトリウム(Na) カリウム(K) クロール(Cl)	人間の体の約60%は水分で、その中には生命活動に重要なミネラルが溶けた状態で存在しています。ナトリウム・カリウム・クロールは電解質と呼ばれるミネラル分の主なもので、体内の水分量やpHを一定に保ったり、神経の伝達や心臓・筋肉を動かすことなどに深く関わっています。体内の水分の調節は腎臓とホルモンの働きによるものです。
	潜血	尿中に血液が含まれていると、腎臓、尿管、膀胱、尿道などに何らかの異常がある可能性があります。			
胸部X線		肺や気管、心臓、大動脈などの異常がわかります。また、側わん症(背骨の歪み)、肋骨や背骨の骨折の跡などがみられることもあります。	痛風	尿酸(UA)	尿酸はほとんどは尿中に排泄されますが、血液中の濃度が一定以上になった場合、痛風となることがあります。また、腎機能を低下させたり、腎結石の原因にもなります。
胃部X線		胃及び食道・十二指腸の一部を写し出します。臓器の形の変化や異常(炎症、潰瘍など)がわかります。			
心電図		心臓の収縮、拡張の時に起きる微小な電流の変化をからだの表面に装着した電極から検出し、波形として記録したものが心電図です。心臓の筋肉の異常、不整脈、心臓肥大などがわかります。	糖代謝	血糖	糖尿病の有無を調べています。血糖とは血液中のブドウ糖のことで、細胞のエネルギー源となる大切な物質です。数値が高い場合は、糖尿病、膵臓がん、ホルモン異常が疑われます。
眼底		瞳孔の奥にある眼底の血管・網膜・視神経を調べる検査です。眼底の血管は人間の体の中でも唯一直接血管を観察できる部位です。網膜剥離や眼底出血、緑内障などの目の病気がわかるだけでなく、動脈硬化の進み具合もわかります。		HbA1c (HbA1c)	ブドウ糖と結びついた血色素(ヘモグロビン)で、約1ヶ月前からの血糖値のコントロール状況を調べることができます。血糖値とは違い、食事の影響を受けません。
血液一般	白血球数	白血球は体内のどこかに細菌による感染があると増加し、これを殺す働きをしています。また、白血球そのものの病気でも増加したり、極端に減少したりします。	その他	ペプシノゲン	胃癌の危険性を知る検査で、胃の壁を覆っている粘膜の萎縮度を判定します。この萎縮度の進行具合で胃癌の発生率が高いか低いかを判断します。陽性と診断されても胃癌であるとは限らず、胃癌になりやすい状態にあるということです
	赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット	貧血を見つける検査です。赤血球には細胞の「ガス交換」をする役割があり、ヘモグロビンが主に働きます。ヘマトクリットは一定の血液量に対する赤血球の割合を表したものです。出血、赤血球を造るのに必要なホルモンの不足、あるいは骨髓の働きが悪くなると赤血球数は減少します。また、原料である鉄が不足するとヘモグロビンが減少し、貧血となります。		ピロリ抗体(濃度) ピロリ抗体(判定)	ピロリ菌は胃の中に好んで住みつき、胃の壁を傷つける細菌です。ピロリ菌の感染は胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃炎の原因になり、さらに胃癌の発生に関わっています。
	血小板	出血した際に止血に関わる血球成分です。数が減少すると出血がとまりにくくなったり、青アザがでやすくなったりします。		PSA	前立腺に特異的な腫瘍マーカーです。前立腺がんの他に前立腺肥大などでも値が上昇します。